

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	卵巢囊腫 Ovarian Cysts				
編號	A31000-Q03-W-M02	制定者	R9 黃麗華	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.8 版/11 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解卵巢囊腫的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

卵巢是經常發生囊腫的部位，正常卵巢大小約 3.5×2.5×1.0 公分，重 4~7 克，若卵巢腫大會引發排卵週期紊亂、良性或惡性變化。卵巢囊腫平均發生年齡為 20~44 歲之間，約 80~85%是良性的。一般在分類上可簡單分為兩大類：一種會自行消失的生理性囊腫，一種則是需要治療的病理性囊腫。

1. 生理性囊腫：與賀爾蒙有關，約佔 80%，病因大多不明，通常會自行消失，如濾泡性囊腫、黃體性囊腫等，生理性囊腫絕大多數沒有症狀，對身體沒有傷害性，也不需要手術治療。在幾個星期內，一般會自行消失。
2. 病理性囊腫：如漿液性囊腫、黏液性囊腫、皮性囊腫畸胎瘤等，約佔所有卵巢腫瘤的 6%，大多是卵巢產生病變，但這些腫瘤並不會擴散而侵犯到其他器官，卻也不會自行消失，因此為了避免腫瘤對附近器官造成壓迫，或是造成破裂、扭轉，手術摘除可能是必要的。

(1)皮性囊腫(Dermoid Cysts)：為最常見的良性畸胎瘤(Texatoma)，可發生於任何年齡，也是女童最常見的卵巢囊腫。此囊腫源生於胚胎之芽細胞，因此包括

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/11

各種不同型態的組織，如頭髮、牙齒、皮脂液和其他鈣化物，甚至有些還會有甲狀腺的組織，通常是單側發生。通常個案不會有症狀，除非因長期嚴重壓迫其他器官，如膀胱、腸道。才會行囊腫切除術，若不切除則會繼續長大造成破裂，導致出血和感染。

(2)子宮內膜囊腫(Endometrial Cysts)：亦稱為巧克力囊腫(Chocolate Cysts)，常與子宮內膜異位症合併發生，是子宮內膜組織異位形成的一部分，常見於卵巢，因其血略呈黑色故名為巧克力囊腫。

(3)多囊性卵巢(Polycystic Ovaries Syndrome, PCOS)：育齡女性常見的內分泌不平衡疾病，約 6~10%，源於黃體促素過度刺激卵巢，導致卵巢內含有多個囊腫，造成內膜過度增生和惡性變化，典型徵候是雄性激素過高與慢性無排卵。

(二) 症狀

頻尿、便秘、性交疼痛、骨盆或下腹部有下墜感，或是有一些女性會抱怨腹部不適或腹圍增加、月經不規則、不孕，或是因荷爾蒙改變而有男性化的特徵。

(三) 常見檢查

定期進行婦科檢查，這是早期發現卵巢腫瘤的一個好方法。

1. 卵巢的腫瘤指標：CA-125，可以作為治療前評估腫瘤進展的大略參考，治療後也可以使用該指標評估治療效果及作為追蹤的工具。
2. 超音波檢查(Ultrasonography)：為第一線的診斷工具，可偵測出體內腫瘤的位置。能早期發現子宮、卵巢或膀胱等器官病變。腹部超音波檢查需於檢查前先漲尿有助顯像；陰道超音波檢查則於檢查前排空膀胱。
3. 電腦斷層(CT scan)：利用電腦集結 X 光攝影以獲得體內更精密的影像，能偵測出直徑僅為 0.3 釐米以上的腫瘤，並能辨別是否有惡性組織細胞的存在。做此檢查前需填寫同意書、禁食 4-6 小時、置入 20 號或 22 號 IV Lock or T-connector、更換手術衣、除去身上金屬飾物、需有 BUN 及 Cr.的報告等準備，檢查後多休息即可。
4. 核磁共振(MRI)：不具放射線的影像檢查工具，主要是利用強力磁場，提供軟組

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/11

織清晰的影像，可看出極小的腫瘤。做此檢查前需填寫同意書、禁食 4-6 小時、置入 20 號或 22 號 IV Lock or T-connector、更換手術衣、除去身上金屬飾物等準備，檢查後多休息即可。

(四) 常見治療

卵巢囊腫中的小囊腫，不需要做治療，只需每 3 個月至 6 個月定期返診，以超音波追蹤囊腫大小即可。若卵巢囊腫變大或是已出現症狀時，外科手術是常採取的治療方式，但須考慮個案年齡、腫瘤位置、症狀、大小和是否考慮保留生殖能力。

1. 腹腔鏡(video/laparoscopy)：

- (1)當囊腫持續 8 週未消失時，會在肚臍下緣及下腹部處開 2-4 個約 1-2 公分的小洞，打入二氧化碳，將肚子鼓脹起來，從肚臍放入內視鏡，切除囊腫部位及抽吸囊腫的液體。
- (2)手術後腹部有 2-4 個約 1-2 公分傷口，需拆線，通常於出院後第一次回診拆線。此手術有可能會在腹部放置 1 條引流管，引流腹內血水，一般引流液量約 <50ml/天可依醫囑移除之。
- (3)優點有手術後傷口小、復原較迅速、縮短住院日。

2. 全子宮及兩側輸卵管卵巢切除(TAH+BSO)：

- (1)已停經或無生育打算的女性，為了避免卵巢囊腫轉為惡性腫瘤，故行全切除手術。
- (2)手術後下腹部有一橫式或直式的傷口，約 10-15 公分。橫式傷口無需拆釘；直式傷口因外層採釘子固定，需拆釘，一般視傷口癒合情況約手術後 5-7 天拆半釘，另一半釘通常於隔天或數天後回門診再拆。

3. 單側輸卵管卵巢切除(USO)：

- (1)當卵巢囊腫大到無法自行吸收，且有可能會擠壓並破壞正常的卵巢時，必須以手術切除單側卵巢，以避免囊腫破裂或繼續生長。
- (2)手術後下腹部有一橫式的傷口，約 10-15 公分，無需拆線。

(五) 護理問題

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/11

1. 尋求（特定的）健康協助／與缺乏疾病、治療方式、危險性及合併症等相關資訊有關。
2. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於治療的相關知識有關。
3. 疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關。
4. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關。

（六）護理措施

1. 尋求（特定的）健康協助／與缺乏疾病、治療方式、危險性及合併症等相關資訊有關
 - (1)主動向個案解釋本疾病的特性、治療及預後。
 - (2)做任何檢查及治療前，須向個案解釋目的及注意事項，並根據其對疾病的認知及疑問予以適當的解釋。
 - (3)若需手術時，需細心的給予手術前的衛教，包括手術的過程、有關的知識護理措施；手術後，護理人員需評估個案身體功能的恢復並執行手術後照護的注意事項。
2. 焦慮感受／與對於健康的威脅、缺乏有關於治療的相關知識有關
 - (1)評估個案焦慮程度及主要原因。
 - (2)鼓勵及引導個案說出心中的感受和想法，以及目前不適的症狀，並給予適當的醫療處置及護理。
 - (3)運用同理心，耐心地傾聽個案心中的感受和想法，尋找引起焦慮的原因。
 - (4)主動提供正確的疾病及治療的相關資訊給個案，適時地澄清及修正其錯誤的觀念，以減輕個案的焦慮感。
 - (5)執行醫療處置或護理照護前，應給予詳細解釋其準備工作及注意事項，並提供衛教單張閱讀，以減輕個案的不安感。
 - (6)執行醫療處置或護理照護時，應注重個案之隱私，勿過度裸露個案身體隱私部位，必要時用屏風遮擋，請異性迴避。男性醫師幫女性個案做婦科檢查時，女性護理人員應要陪同在旁。

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/11

- (7)利用行為或認知策略，教導個案規律的呼吸、放鬆的技巧（如按摩）、冥想等，以減輕焦慮。
- (8)轉移個案注意力，如聽音樂、聊天。
- (9)教導個案手術後咳嗽、翻身、下床活動時，如何固定傷口，減少傷口疼痛，且會依當時疼痛程度給予控制疼痛的處置，以減輕個案害怕傷口疼痛之焦慮。
- (10)讓個案瞭解手術後可能存在的管子及其重要性，以減少焦慮。
- (11)介紹相同的個案，彼此經驗分享。
- (12)多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減少焦慮。
- (13)隨時評估個案焦慮改善狀態。
- (14)若個案焦慮感持續無法改善，必要時依醫囑給予藥物治療，如：鎮靜、精神神經安定劑。

3.疼痛不適／與疾病引起的疼痛、手術後傷口疼痛有關

- (1)評估個案的疼痛部位、程度（0 不痛～10 最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（刺痛或拍動痛、深沉或表淺），並記錄疼痛的變化。
- (2)監測生命徵象的變化，如：疼痛時，血壓上升，心跳、呼吸次數增加。
- (3)與個案或家屬確認引發疼痛的因素，如個人的、與疾病有關的、與治療有關的。
- (4)與個案或家屬共同討論減少或排除疼痛的方法。
- (5)評估個案使用疼痛控制方法的意願，在個案選擇疼痛控制方法時，如止痛劑、止痛藥、自控式止痛等，應給予教導與支持。
- (6)教導個案疼痛時採取舒適的臥位，如側臥、半坐臥、軀體彎曲位或端坐臥勢。
- (7)鼓勵個案運用熱敷、按摩背部及休息來緩解疼痛的不適感。
- (8)教導個案放鬆技巧或轉移注意力，如漸進式肌肉放鬆法、按摩、聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天，以減緩疼痛。
- (9)教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。
- (10)避免腹部用力，如哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/11

(11)多探視、陪伴及心理支持，增加安全感，以減緩疼痛。

4. 易感染／與手術後傷口、引流管留存有關

(1)每班監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。

(2)每班監測引流液之量、顏色、氣味、性質及周圍皮膚之完整性。

(3)監測可顯示感染的實驗室檢查，並報告異常現象。

(4)教導個案或主要照顧者炎症症狀，如紅、腫、熱、痛及徵象，如發燒、流膿，若有以上之情形應通知醫護人員。

(5)教導個案或主要照顧者引流管勿高於放置或穿刺部位，維持引流管之通暢，並教導及協助翻身或活動方式，避免壓迫引流管。

(6)教導個案或主要照顧者預防感染的方法，如接觸個案前洗手、保持傷口清潔及乾燥、避免壓迫傷口、注意衛生、營養充足等，並評估其瞭解程度。

(7)視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。

(8)若個案情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。

(9)建議採少量多餐，以增進食量，必要時依醫囑給予維他命、營養素或適量輸液。

(10)評估個案營養狀況，給予飲食衛教。

(七) 衛教指導

1. 飲食方面

(1)一般而言，採腹腔鏡手術於手術後，視醫囑禁食 8 小時；開腹手術視醫囑禁食至排氣，或有腸蠕動時，依醫囑可進食。

(2)可以開始進食時，應先喝白開水約 30-50c.c.，若無噁心、嘔吐腹脹、腹痛、腸絞痛後，可吃白飯、新鮮自烹白稀飯、麵條等軟質飲食，勿吃太快太多，避免腸絞痛。沒有任何不適時，可以恢復正常飲食，採少量多餐，不要太油膩及太鹹。

(3)建議個案 1 週內少攝取刺激性食物如辣椒、咖啡；少進食易產氣食物如牛奶、

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/11

蛋、豆類製品、地瓜、麵包等，以防腹脹不適；增加水份攝取，以避免便秘；
建議 2 週內避免進食含人參、麻油、酒等食物，避免影響傷口癒合。

2. 傷口方面

- (1)衛教腹腔鏡手術後腹部可能有 2-4 個小傷口，或是開腹手術後會有 1 個約 10-15 公分橫式或直式傷口，且必要時醫師有可能會放置傷口引流管，可能會引起身體不適。
- (2)每班觀察傷口有無紅、腫、熱、痛，或不正常的分泌物及傷口恢復狀況。
- (3)手術後當天不會換藥，手術後第三天會由醫師換藥，之後每 2 天換藥一次，或視當時傷口情況換藥。
- (4)換藥步驟及方法：將無菌食鹽水滴至無菌棉棒，以傷口為中心點，由內向外塗擦清潔至傷口周圍外至少 5 公分處，再將無刺激性優點藥水滴至無菌棉棒塗擦消毒，約停留 20-30 秒，最後再使用無菌食鹽水將優點藥水擦去，消毒完畢後再以無菌紗布或無菌敷料覆蓋傷口及黏貼好。
- (5)教導個案需保持傷口及周圍皮膚清潔與乾燥。
- (6)教導腹部傷口約 10-14 天癒合，需保持清潔乾燥。
- (7)出院後建議傷口約 2-3 天換藥，或是不小心弄濕或滲濕時應更換之。

3. 傷口疼痛方面

- (1)教導在傷口換藥後或下床時使用束腹帶，減少腹部傷口牽扯，減輕傷口疼痛。
- (2)衛教 4-6 週內避免提重物，若需提 5 公斤以上重物時，建議可使用束腹帶固定傷口，以避免疼痛。

4. 活動方面

- (1)衛教手術後當天在床上應多翻身或側臥，最好每 2 小時翻身一次，促進血液循環，增加腸蠕動，以預防腸道粘連，並鼓勵個案早期下床活動。
- (2)手術後第二天盡可能採漸進式下床活動，可以先採半坐臥，若未感不適則可以採坐臥，再坐於床邊，慢慢站起走動，全程需由家屬或朋友陪伴，以防止跌倒之虞。

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/11

(3)衛教避免長時間坐或站、勿激烈運動，如機車、騎腳踏車、開車長途旅行、爬山、游泳。

5. 衛生方面

(1)手術後導尿管會留置大約 1 天，導尿管留置期間會給予會陰沖洗及導尿管的護理，並視情況協助移除導尿管。視醫囑協助導尿管膀胱訓練，之後再視訓練情形移除導尿管。移除尿管後，需注意第一次解尿時間（4-6 小時內自解）及記錄排尿量與觀察尿液顏色。

(2)手術後若陰道有血狀排泄物，應勤換產墊或棉墊，以保持乾淨，避免感染。

(3)如廁後衛生紙應由前往後擦拭，勤換棉墊，避免感染。

(4)個案身體清潔之照護，手術後先以擦拭方式為主，醫師會視傷口癒合狀況，評估是否可以開始沐浴。若可以沐浴時，建議宜採淋浴方式，勿盆浴及陰道灌洗，以避免傷口感染。

6. 性方面：需在醫師診察傷口癒合後，視情況約 2-6 週可恢復性生活。

7. 其他方面：

(1)跟個案衛教術後會有肋骨及肩部酸痛不適情形，約會持續 2-3 天。

(2)出院後若有以下情形應立即回診：傷口有紅、腫、熱、痛及滲出液情形；體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 以上；解尿困難、疼痛、頻尿、有灼熱感；陰道出血量多呈鮮紅色、惡臭。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/11

六、參考資料

- (一) 馮容莊、葉月珍、呂美芬、湯玉英、祁安美、林麗珠、李惠玲、潘婉琳、陳淑貞、田聖芳、張芳維、趙興隆、任士熙、張碧芬(2019)．實用婦科護理（六版）．台北：華杏。
- (二) 呂亦嵐、李宛蓉、陳柑杏、賴淑芳、吳金枝(2024)．一位卵巢畸胎瘤導致抗 NMDA 受體腦炎個案之照護經驗．領導護理，26(1)，56-68。
- (三) 趙偉廷、劉家豪、王鵬惠(2024)．卵巢顆粒細胞瘤與腫瘤繼發血液高雄性素之案例報告．婦癌醫學期刊，59，19-23。
- (四) Mobeen, S., & Apostol, R. (2022). Ovarian Cyst. National Library of Medicine. StatPearls Publishing.

七、附件

(略)

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	增加及修改定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題及衛教指導之內容	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部 2.修改錯別字	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.第三項第(一)目部份內容刪修。 2.更新第六項文獻參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第三項第七目之 1(2)內容修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	卵巢囊腫	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.7	1. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.8	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。